



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN
PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD)
RS PRIMA HUSADA MALANG**

Jl. Banjararum Selatan No. 3-7 Mondoroko - Singosari, Malang

Telp. 0341-458679, 458916, Fax. 441874

Email : sekretariat@malang.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada
Nomor 1005.2/I-PDM/DIR/XI/2025

Tentang

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (FRAUD)

Penanggung Jawab



dr. Amanda Firmandani

Disetujui oleh:
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP

Ditetapkan oleh:
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya, Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) RS Prima Husada Malang ini dapat diselesaikan dengan baik.

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang padat modal, padat karya, dan padat regulasi. Dalam menjalankan operasionalnya, terutama di era jaminan kesehatan nasional dan digitalisasi sistem kesehatan saat ini, tantangan yang dihadapi tidak hanya berfokus pada mutu klinis, melainkan juga pada aspek tata kelola keuangan dan administrasi yang akuntabel. Praktik kecurangan (*fraud*) merupakan ancaman serius yang dapat merusak integritas pelayanan, merugikan keuangan rumah sakit, serta menurunkan kepercayaan masyarakat dan mitra kerja.

Pedoman ini disusun sebagai wujud komitmen nyata manajemen RS Prima Husada Malang untuk membangun ekosistem kerja yang bersih, transparan, dan menjunjung tinggi nilai-nilai etika profesi serta hukum yang berlaku. Buku pedoman ini memuat panduan komprehensif mengenai definisi *fraud*, langkah-langkah preventif, metode deteksi dini, hingga mekanisme penanganan dan pengenaan sanksi yang tegas bagi setiap pelanggaran.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Tim Penyusun, jajaran manajemen, Komite Medik, Komite Keperawatan, serta seluruh pihak yang telah berkontribusi dedikatif dalam perumusan pedoman ini.

Pedoman ini tidak akan memberikan dampak optimal tanpa adanya kesadaran dan kepatuhan dari seluruh *civitas hospitalia*. Oleh karena itu, menjadi kewajiban kita bersama untuk memahami, menginternalisasi, dan menerapkan pedoman ini dalam aktivitas pelayanan sehari-hari demi mewujudkan RS Prima Husada Malang yang maju, tepercaya, dan bebas dari *fraud*.

Semoga pedoman ini dapat menjadi kompas moral dan operasional yang membawa berkah serta manfaat bagi kemajuan rumah sakit dan keselamatan pasien yang kita layani.

Malang, 05 November 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



dr. Resti Lestantini, M. Kes

TIM PENYUSUN

PENGARAH

- 1. Dr. dr. Aslichah, M.Kes., AFP
- 2. dr. Resti Lestantini, M. Kes

PENYUSUN

- 1. dr. Amanda Firmandani
- 2. Puput Sekar Nari Ratih, Amd. Keb, SE
- 3. Dini Dwi Oktaviana, Amd. RMIK

DAFTAR ISI

SAMPUL i

LEMBAR PENGESAHAN..... ii

TIM PENYUSUSN..... iii

KATA PENGANTAR..... iv

DAFTAR ISI v

PERATURAN DIREKTUR vi

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Latar Belakang 1

 1.2 Maksud dan Tujuan 2

 1.3 Pengertian 3

BAB II RUANG LINGKUP 6

 2.1 Definisi..... 6

 2.2 Batasan Subjek (Personel yang terkait) 6

 2.3 Batasan Objek (Area Kegiatan dan Pelayanan Rawan Fraud)..... 7

BAB III PEMBAHASAN..... 6

 3.1 Komitmen Rumah Sakit Terhadap Pencegahan dan Penanganan Fraud 9

 3.2 Jenis Fraud di Rumah Sakit..... 9

 3.3 Prinsip Anti fraud 11

 3.4 Potensi Kejadian Fraud di Tiap Unit Rumah Sakit..... 12

 3.5 Strategi Anti Fraud 14

 3.6 Sistem dan Alur Pelaporan 15

BAB IV PENUTUP 18

PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**NOMOR 1005.2/I-PDM/DIR/XI/2025****TENTANG****PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD)****DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,**

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*), RS Prima Husada Malang berkomitmen untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu, adil, transparan, dan akuntabel;
 - bahwa praktik kecurangan (*fraud*) di lingkungan rumah sakit merupakan ancaman serius yang dapat merugikan keuangan institusi, menurunkan mutu pelayanan, mencederai keselamatan pasien, serta merusak integritas profesi dan nama baik rumah sakit;
 - bahwa sejalan dengan pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) serta guna memenuhi standar akreditasi rumah sakit terkait kendali mutu dan kendali biaya, diperlukan sistem yang komprehensif untuk mencegah, mendeteksi, dan menangani setiap bentuk potensi kecurangan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin (a), (b), dan (c), maka perlu ditetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) yang disahkan melalui Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Malang.
- Mengingat :
- Undang – Undnag Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (FRAUD);
 - Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;
 - Kepdirjen Nomor HK.02.02.D.47104.2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;
 - Kepdirjen Nomor 43961.2024 tentang Revisi 02 Pedoman Survei Akreditasi Rumah Sakit 7 Agustus 2024;
 - Keputusan Direktur Utama Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor 1042.92/DPM/I-KEP/DIR/IX/2025 tentang Pengangkatan PLT Direktur RS Prima Husada Malang.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD).**

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1****Pengertian**

Dalam Peraturan Direktur ini yang dimaksud dengan:

- (1) Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang

menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Fraud (dalam bahasa Indonesia diserap menjadi Kecurangan) adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja oleh seseorang atau sekelompok orang, dengan cara manipulasi data, mengelabui atau melanggar hukum untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah;
- (3) Pencegahan Fraud adalah seluruh upaya yang dilakukan secara sistematis untuk mengurangi peluang terjadinya fraud melalui penguatan tata kelola, pengendalian internal, manajemen risiko, pendidikan, serta budaya integritas.
- (4) Deteksi Fraud adalah serangkaian kegiatan untuk mengidentifikasi indikasi, potensi, atau kejadian fraud melalui pemantauan, audit, evaluasi, pelaporan, maupun mekanisme pengawasan lainnya.
- (5) Investigasi Fraud adalah proses pemeriksaan secara objektif, independen, dan terdokumentasi terhadap dugaan fraud untuk memperoleh fakta dan bukti yang memadai.
- (6) Pelapor (Whistleblower) adalah setiap orang yang menyampaikan informasi mengenai dugaan fraud yang diketahuinya dengan itikad baik.
- (7) Whistleblowing System (WBS) adalah mekanisme pelaporan dugaan pelanggaran atau fraud yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
- (8) Pengendalian Internal adalah proses yang dirancang untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan organisasi dapat dicapai melalui efektivitas operasional, keandalan pelaporan, perlindungan aset, dan kepatuhan terhadap peraturan.
- (9) Manajemen Risiko adalah proses sistematis dalam mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, dan memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan rumah sakit.
- (10) Insiden Fraud adalah setiap tindakan yang telah terbukti atau diduga memenuhi unsur fraud berdasarkan hasil identifikasi awal maupun investigasi.
- (11) Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara rumah sakit yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.
- (12) Kode Etik adalah seperangkat norma yang menjadi pedoman perilaku seluruh insan rumah sakit dalam menjalankan tugas secara profesional, jujur, dan bertanggung jawab.
- (13) Staf Rumah Sakit adalah seluruh pemilik, komisaris, direksi, tenaga medis, tenaga kesehatan, pegawai, tenaga kontrak, mahasiswa praktik, relawan, mitra kerja, vendor, maupun pihak lain yang melakukan aktivitas di lingkungan rumah sakit.
- (14) Pengendalian Fraud adalah seluruh kebijakan dan prosedur untuk mencegah, mendeteksi, serta menangani fraud.
- (15) Investigasi Internal adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh tim yang ditunjuk Direktur terhadap dugaan fraud.
- (16) Sanksi adalah tindakan administratif, kepegawaian, perdata

maupun pidana sesuai ketentuan yang berlaku. Phantom Billing adalah menagihkan biaya pengobatan atau tindakan medis kepada BPJS/ Asuransi, dimana tindakan tersebut tidak pernah dilakukan kepada pasien;

- (17) Upcoding adalah mengubah atau menaikkan kode diagnosis penyakit di rekam medis menjadi jenis penyakit yang lebih parah/ mahal agar rumah sakit mendapatkan klaim bayaran yang lebih tinggi;
- (18) Kickback (suap) adalah menerima komisi ilegal dari vendor farmasi atau alat kesehatan secara rahasia untuk keuntungan pribadi saat proses pengadaan barang rumah sakit;

Pasal 2 Ruang Lingkup

- (1) Pedoman ini berlaku bagi seluruh kegiatan penyelenggaraan rumah sakit.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pengawas dan Direksi Rumah Sakit
 - b. Pelayanan Medis;
 - c. Pelayanan Penunjang Medis;
 - d. Pelayanan Bagian Umum;

Pasal 3 Prinsip Penyelenggaraan

Pencegahan dan penanganan fraud dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- (1) Integritas;
- (2) Kejujuran;
- (3) Transparansi;
- (4) Akuntabilitas;
- (5) Independensi;
- (6) Objektivitas;
- (7) Profesionalisme;
- (8) Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (9) Kerahasiaan;
- (10) Keadilan;
- (11) Perlindungan terhadap pelapor yang beritikad baik;
- (12) Manajemen risiko;
- (13) Pengendalian internal; dan
- (14) Perbaikan berkelanjutan.

Pasal 4 Sasaran

- (1) Pedoman ini berlaku bagi seluruh insan Rumah Sakit.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Pemilik atau Representasi Pemilik;
 - b. Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas;
 - c. Direksi;
 - d. seluruh komite;

-
- e. Satuan Pengawas Internal;
 - f. tenaga medis;
 - g. tenaga kesehatan;
 - h. tenaga nonkesehatan;
 - i. pegawai tetap maupun tidak tetap;
 - j. tenaga alih daya;
 - k. mahasiswa praktik;
 - l. relawan;
 - m. penyedia barang dan jasa;
 - n. mitra kerja; dan
 - o. pihak lain yang melakukan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit.

Pasal 5 Kebijakan Umum

Rumah sakit berkomitmen untuk:

- (1) Menerapkan budaya anti fraud;
- (2) Menerapkan zero tolerance terhadap fraud;
- (3) Mengembangkan sistem pengendalian internal;
- (4) Mengembangkan manajemen risiko;
- (5) Menyediakan whistleblowing system;
- (6) Menjamin kerahasiaan pelapor;
- (7) Melakukan investigasi secara objektif;
- (8) Memberikan sanksi secara adil;
- (9) Melakukan perbaikan sistem;
- (10) Melakukan monitoring secara berkelanjutan.

BAB II ORGANISASI DAN TANGGUNG JAWAB PENCEGAHAN

Pasal 6 Penyelenggara Program Anti Fraud

- (1) Program pencegahan dan penanganan Fraud di selenggarakan secara terpadu oleh seluruh unsur organisasi Rumah sakit.
- (2) Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh direktur melalui

Pasal 7 Tanggung Jawab Pemilik atau Representasi Pemilik

Pemilik atau Representasi Pemilik bertanggung jawab:

- (1) Menetapkan arah kebijakan penerapan budaya anti fraud;
- (2) Mendukung penyediaan sumber daya yang diperlukan;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap penerapan tata kelola yang baik; dan
- (4) Mengevaluasi efektivitas program pencegahan fraud.

Pasal 8 Tanggung Jawab Direktur

Direktur bertanggung jawab

-
- (1) Menetapkan kebijakan dan strategi pencegahan fraud;
 - (2) Membentuk tim anti fraud;
 - (3) Menyediakan sumber daya yang memadai;
 - (4) Memastikan terselenggaranya sistem pengendalian internal;
 - (5) Memastikan tersedianya mekanisme pelaporan fraud;
 - (6) Menetapkan tindak lanjut hasil investigasi;
 - (7) Memberikan sanksi sesuai kewenangannya; dan
 - (8) Melaporkan pelaksanaan program anti fraud kepada pemilik atau representasi pemilik.

Pasal 9 Tim Anti Fraud

- (1) Direktur membentuk Tim Anti Fraud melalui Keputusan Direktur.
- (2) Tim Anti Fraud paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. Direktur
 - b. Kepala Bidang
 - c. Komite Mutu
 - d. SDM
 - e. Verifikator
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Anti Fraud dapat melibatkan unit kerja terkait sesuai kebutuhan investigasi.

Pasal 10 Tugas dan Wewenang Tim Anti Fraud

- (1) Tugas
Tim Anti Fraud mempunyai tugas:
 - a. menyusun program kerja pencegahan dan penanganan fraud sesuai dengan kebijakan Rumah Sakit;
 - b. melakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan risiko fraud pada seluruh proses bisnis dan pelayanan Rumah Sakit;
 - c. menyusun strategi mitigasi risiko fraud serta memberikan rekomendasi perbaikan sistem pengendalian internal;
 - d. menyusun dan mengembangkan pedoman, standar operasional prosedur, serta instrumen pencegahan dan penanganan fraud;
 - e. melaksanakan sosialisasi, edukasi, dan peningkatan budaya integritas serta kesadaran anti fraud kepada seluruh insan Rumah Sakit;
 - f. menerima, mencatat, dan melakukan verifikasi awal terhadap setiap laporan dugaan fraud yang diterima melalui mekanisme pelaporan yang ditetapkan;
 - g. melakukan investigasi atau mengoordinasikan pelaksanaan investigasi terhadap dugaan fraud sesuai kewenangan;
 - h. menyusun laporan hasil investigasi beserta rekomendasi tindak lanjut kepada Direktur;
 - i. melakukan pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut hasil investigasi dan rekomendasi perbaikan;
 - j. melakukan evaluasi efektivitas penerapan program anti fraud secara berkala;
 - k. menyusun laporan pelaksanaan program pencegahan dan

penanganan fraud kepada Direktur secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan; dan

- I. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur sepanjang berkaitan dengan pencegahan dan penanganan fraud.

(2) Wewenang

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Anti Fraud berwenang:

- a. meminta data, dokumen, informasi, dan keterangan dari seluruh unit kerja, pegawai, maupun pihak terkait sesuai kebutuhan investigasi;
- b. melakukan klarifikasi, wawancara, observasi, dan pemeriksaan terhadap pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam dugaan fraud;
- c. mengakses dokumen, rekaman, sistem informasi, dan bukti lain sesuai kewenangan serta ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. melakukan koordinasi dengan Satuan Pengawas Internal, Komite, unit kerja terkait, auditor internal maupun auditor eksternal dalam pelaksanaan investigasi;
- e. mengusulkan pembentukan Tim Investigasi khusus apabila dugaan fraud memerlukan pemeriksaan yang lebih mendalam;
- f. memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai tindakan administratif, perbaikan sistem, pemulihan kerugian, maupun langkah hukum sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. meminta unit kerja terkait untuk melaksanakan tindakan pengamanan terhadap dokumen, aset, data, atau barang bukti yang diperlukan dalam proses investigasi;
- h. melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rekomendasi hasil investigasi dan meminta laporan tindak lanjut dari unit kerja terkait; dan
- i. memberikan rekomendasi kepada Direktur mengenai pengembangan sistem pengendalian internal dan manajemen risiko sebagai upaya pencegahan fraud.

(3) Tanggung Jawab

Tim Anti Fraud bertanggung jawab

- a. melaksanakan seluruh tugas dan fungsi pencegahan serta penanganan fraud secara profesional, independen, objektif, transparan, dan akuntabel;
- b. menjaga kerahasiaan identitas pelapor, informasi, dokumen, data, dan seluruh hasil investigasi sesuai ketentuan yang berlaku;
- c. memastikan setiap laporan dugaan fraud diproses secara tepat waktu, objektif, dan tanpa diskriminasi;
- d. menjaga integritas, independensi, dan menghindari benturan kepentingan dalam setiap pelaksanaan tugas;
- e. memastikan seluruh proses investigasi dilaksanakan berdasarkan bukti yang sah, fakta yang dapat dipertanggungjawabkan, dan prinsip *due process*;
- f. memberikan rekomendasi yang objektif berdasarkan hasil investigasi tanpa dipengaruhi kepentingan pihak mana pun;

-
- g. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas penerapan program anti fraud di seluruh unit kerja;
 - h. menyampaikan laporan pelaksanaan program anti fraud secara berkala kepada Direktur beserta rekomendasi perbaikan;
 - i. mengoordinasikan pelaksanaan tindak lanjut atas hasil investigasi bersama unit kerja terkait;
 - j. meningkatkan kompetensi anggota Tim Anti Fraud melalui pendidikan, pelatihan, dan pengembangan kapasitas secara berkelanjutan; dan
 - k. mempertanggungjawabkan seluruh pelaksanaan tugas dan penggunaan kewenangannya kepada Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal Rumah Sakit.

Pasal 11

Kewajiban Staf Rumah Sakit

Setiap Staf Rumah Sakit wajib:

- (1) Mematuhi seluruh ketentuan dalam pedoman ini;
- (2) Menjaga integritas dan profesionalisme;
- (3) Menghindari benturan kepentingan;
- (4) Menjaga kerahasiaan informasi;
- (5) Melaksanakan tugas sesuai kewenangan;
- (6) Tidak melakukan segala bentuk fraud; dan
- (7) Melaporkan setiap dugaan fraud yang diketahuinya.

Pasal 12

Hak Pelapor

- (1) Pelapor yang menyampaikan laporan dengan itikad baik berhak memperoleh:
 - a. Perlindungan identitas
 - b. Perlindungan dari ancaman, intimidasi, maupun tindakan balasan
 - c. perlakuan yang adil selama proses investigasi; dan
 - d. informasi mengenai tindak lanjut laporan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menghapus kewajiban pelapor untuk memberikan keterangan yang benar apabila diperlukan dalam proses investigasi.

BAB III

RISIKO FRAUD

Pasal 13

Identifikasi Risiko Fraud

- (1) Identifikasi risiko fraud dilakukan terhadap seluruh proses bisnis, pelayanan, administrasi, dan kegiatan operasional Rumah Sakit.
- (2) Identifikasi risiko fraud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Identifikasi aktivitas yang berpotensi menimbulkan fraud;
 - b. Identifikasi faktor penyebab dan peluang terjadinya fraud;
 - c. Identifikasi pihak yang berpotensi melakukan atau terdampak fraud;

- d. Identifikasi kelemahan sistem pengendalian internal; dan
 - e. Identifikasi dampak yang dapat ditimbulkan terhadap pelayanan, keuangan, aset, reputasi, dan kepatuhan rumah sakit.
- (3) Hasil identifikasi risiko fraud didokumentasikan dalam register risiko fraud.

Pasal 14

Area Berisiko Tinggi

- (1) Tim Anti Fraud melakukan pemetaan terhadap area yang memiliki tingkat risiko fraud tinggi.
- (2) Area berisiko tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain
 - a. Pelayanan pasien;
 - b. Klaim pembiayaan pelayanan kesehatan;
 - c. Pengadaan barang dan jasa;
 - d. Pengelolaan obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai;
 - e. Pengelolaan kas dan keuangan;
 - f. Pengelolaan aset;
 - g. Pengelolaan sumber daya manusia;
 - h. Teknologi informasi;
 - i. Pengelolaan rekam medis dan data kesehatan;
 - j. Kerja sama dengan pihak ketiga; dan
 - k. Kegiatan lain yang berdasarkan hasil penilaian memiliki risiko fraud tinggi.

Pasal 15

Mitigasi Risiko Fraud

- (1) Terhadap setiap risiko fraud yang telah diidentifikasi wajib disusun langkah mitigasi.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. Penyempurnaan Kebijakan Dan Prosedur;
 - b. Penguatan Sistem Pengendalian Internal;
 - c. Pemisahan Fungsi (*Segregation Of Duties*);
 - d. Pembatasan Kewenangan;
 - e. Peningkatan Pengawasan;
 - f. Pemanfaatan Teknologi Informasi;
 - g. Peningkatan Kompetensi Pegawai;
 - h. Rotasi Pegawai Sesuai Ketentuan; Dan
 - i. Tindakan Pengendalian Lainnya Sesuai Kebutuhan.

BAB IV

PENCEGAHAN KECURANGAN FRAUD

Pasal 16

Kebijakan Pencegahan Fraud

- (1) Rumah Sakit menerapkan kebijakan pencegahan fraud sebagai bagian dari tata kelola organisasi.
- (2) Pencegahan fraud dilaksanakan secara menyeluruh, berkesinambungan, dan menjadi tanggung jawab seluruh insan Rumah Sakit.

Pasal 17
Budaya Integritas

- (1) Rumah Sakit membangun budaya integritas sebagai landasan dalam pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan dan operasional.
- (2) Budaya integritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan melalui:
 - a. keteladanan pimpinan;
 - b. kepatuhan terhadap kode etik;
 - c. penerapan nilai-nilai organisasi;
 - d. komunikasi yang terbuka;
 - e. transparansi dalam pengambilan keputusan; dan
 - f. komitmen terhadap perilaku anti fraud.

Pasal 18
Manajemen Risiko

- (1) Pencegahan fraud dilakukan melalui penerapan manajemen risiko pada seluruh proses bisnis Rumah Sakit.
- (2) Setiap unit kerja wajib mengidentifikasi, menilai, mengendalikan, dan memantau risiko fraud yang menjadi tanggung jawabnya

BAB III
PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal 05 November 2025
PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
NOMOR 1005.2/I-
PDM/DIR/XI/2025 TENTANG
PEDOMAN PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KECURANGAN
(FRAUD)

PEDOMAN PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KECURANGAN (FRAUD)
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

RS Prima Husada merupakan rumah sakit yang berada di bawah pengelolaan PT Disa Prima Medika dan menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara paripurna kepada masyarakat. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, RS Prima Husada bekerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan, antara lain BPJS Kesehatan sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), perusahaan asuransi, badan usaha, institusi pemerintah, serta mitra kerja lainnya. Dalam penyelenggaraan pelayanan tersebut, rumah sakit wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pelayanan kesehatan, standar akreditasi rumah sakit, serta kebijakan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan instansi terkait.

Kompleksitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan, besarnya pengelolaan sumber daya, tingginya volume transaksi keuangan, serta perkembangan teknologi informasi dalam sistem pelayanan rumah sakit meningkatkan risiko terjadinya penyimpangan atau kecurangan (*fraud*). Risiko tersebut dapat terjadi pada seluruh proses bisnis rumah sakit, baik dalam pelayanan klinis maupun nonklinis, pengelolaan keuangan, klaim pembiayaan, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, teknologi informasi, sumber daya manusia, maupun bentuk kegiatan lainnya yang berkaitan dengan penyelenggaraan rumah sakit.

Kecurangan (*fraud*) merupakan tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk memperoleh keuntungan pribadi atau pihak tertentu melalui penyalahgunaan kewenangan, manipulasi, pemalsuan, penggelapan, benturan kepentingan, penyampaian informasi yang tidak benar, maupun tindakan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan internal rumah sakit. Tindakan tersebut dapat dilakukan oleh pegawai, tenaga medis, tenaga kesehatan, mitra kerja, penyedia barang dan jasa, maupun pihak lain yang memiliki hubungan kerja dengan rumah sakit.

Fraud dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan dapat berupa manipulasi data pelayanan, ketidaksesuaian dokumentasi rekam medis, penyimpangan dalam pengajuan klaim, penyalahgunaan aset dan fasilitas rumah sakit, pengadaan barang dan jasa yang tidak sesuai ketentuan, penyalahgunaan wewenang, penerimaan gratifikasi, benturan kepentingan, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang berpotensi menimbulkan kerugian finansial maupun nonfinansial. Selain berdampak terhadap kerugian ekonomi, fraud juga dapat menurunkan mutu pelayanan, mengganggu keselamatan pasien, merusak reputasi rumah sakit, menurunkan kepercayaan masyarakat, serta menghambat pencapaian tujuan organisasi.

Perkembangan digitalisasi pelayanan kesehatan melalui implementasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), Rekam Medis Elektronik (RME), sistem klaim elektronik, dan berbagai aplikasi pendukung pelayanan telah meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pelayanan kesehatan. Namun demikian, perkembangan tersebut juga menghadirkan risiko baru berupa penyalahgunaan akses sistem, manipulasi data elektronik, pelanggaran keamanan informasi, serta bentuk fraud berbasis teknologi apabila tidak didukung oleh sistem pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata kelola teknologi informasi yang memadai.

Sebagai organisasi pelayanan kesehatan yang berorientasi pada mutu, keselamatan pasien, kepatuhan, dan keberlanjutan usaha, RS Prima Husada berkomitmen untuk menerapkan prinsip **Good Hospital Governance** melalui penguatan budaya integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap seluruh ketentuan yang berlaku. Upaya tersebut diwujudkan melalui penerapan sistem pencegahan dan penanganan fraud yang terintegrasi dengan manajemen risiko, pengendalian internal, peningkatan mutu, keselamatan pasien, serta mekanisme pengawasan yang efektif.

Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Fraud ini juga merupakan implementasi dari ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) serta Penetapan Sanksi Administratif terhadap Kecurangan (*Fraud*) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, serta berbagai ketentuan lain yang mengatur tata kelola rumah sakit, pengendalian internal, manajemen risiko, dan kepatuhan organisasi. Meskipun demikian, pedoman ini disusun tidak hanya untuk memenuhi ketentuan dalam penyelenggaraan Program JKN, tetapi sebagai pedoman umum pencegahan dan penanganan fraud pada seluruh aktivitas penyelenggaraan rumah sakit.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, RS Prima Husada menetapkan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Fraud sebagai acuan bagi seluruh insan rumah sakit dalam membangun budaya anti fraud, meningkatkan kesadaran terhadap risiko fraud (*fraud awareness*), memperkuat sistem pencegahan, deteksi, pelaporan, investigasi, penanganan, monitoring, dan evaluasi secara berkesinambungan. Pedoman ini diharapkan menjadi landasan dalam mewujudkan penyelenggaraan rumah sakit yang berintegritas, transparan, akuntabel, profesional, patuh terhadap regulasi, serta mampu memberikan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terpercaya bagi masyarakat.

1.2 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (*Fraud*) ini dimaksudkan sebagai panduan resmi dan standar acuan kerja bagi jajaran direksi, manajemen, komite fungsional, tenaga medis, tenaga kesehatan lain, serta seluruh staf non-klinis di RS Prima Husada Malang.

Pedoman ini menjadi instrumen hukum dan operasional internal untuk mengidentifikasi celah kerawanan, membangun sistem kendali mutu dan kendali biaya yang transparan, serta menyamakan persepsi dalam mendeteksi, melaporkan, dan menindaklanjuti segala bentuk tindakan kecurangan (*fraud*) yang dapat merugikan keuangan maupun reputasi rumah sakit.

2. Tujuan Umum

Tujuan umum dari pedoman ini adalah untuk mewujudkan tata kelola rumah sakit yang bersih, akuntabel, dan berintegritas tinggi (*Good Corporate and Clinical Governance*) di RS Prima Husada Malang, serta memastikan seluruh penyelenggaraan pelayanan kesehatan terbebas dari praktik kecurangan guna melindungi aset rumah sakit, hak-hak pasien, dan keberlanjutan program jaminan kesehatan.

3. Tujuan Khusus

- a. Menyusun regulasi dan sistem kendali internal yang ketat di area rawan (seperti pengisian rekam medis, proses koding klaim, kasir, dan pengadaan barang) untuk mempersempit ruang gerak terjadinya tindakan kecurangan.
- b. Membina budaya kerja yang jujur melalui edukasi dan sosialisasi berkala kepada seluruh sivitas hospitalia mengenai jenis-jenis *fraud* dan dampak buruknya terhadap rumah sakit.
- c. Memaksimalkan peran audit klinis (oleh Komite Medik/Keperawatan) dan audit manajerial (oleh Satuan Pemeriksa Internal/Tim Anti-Fraud) dalam memantau kesesuaian antara pelayanan nyata dengan penagihan klaim biaya (*billing*).
- d. Membangun *Whistleblowing System* (WBS) rumah sakit yang tepercaya, rahasia, dan mampu memberikan perlindungan penuh kepada pelapor yang mendeteksi indikasi *fraud*.
- e. Menjadi dasar hukum bagi pihak manajemen dalam melakukan investigasi yang objektif, transparan, serta menjatuhkan sanksi disiplin, klinis, administrasi, maupun hukum yang proporsional bagi pelaku kecurangan.
- f. Menyelaraskan tata kelola keuangan dengan asuhan pasien demi menekan variasi pelayanan yang tidak perlu, mendukung tercapainya program *Zero Complaint*, serta meningkatkan *Patient Experience*.

1.3 Pengertian

1. Rumah Sakit

Yang dimaksud dengan Rumah Sakit adalah seluruh unit pelayanan, unit penunjang, unit administrasi, maupun unit usaha yang berada di bawah pengelolaan RS Prima Husada beserta seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan.

2. Pengertian Fraud (Kecurangan) di Rumah Sakit

Fraud di Rumah Sakit adalah segala bentuk tindakan kecurangan, penipuan, atau perbuatan sengaja yang dilakukan oleh pihak internal (seperti manajemen, staf klinis, tenaga kesehatan, non-klinis) maupun pihak eksternal (seperti pasien, vendor, BPJS/asuransi) dengan cara memanipulasi data, proses, atau informasi keuangan demi memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok secara tidak sah, yang secara langsung maupun tidak langsung mengakibatkan kerugian finansial atau hilangnya efisiensi pada rumah sakit maupun anggaran jaminan kesehatan publik/swasta.

3. Pencegahan Fraud

Pencegahan fraud dilakukan melalui penerapan budaya integritas, sistem pengendalian internal, manajemen risiko, kepatuhan terhadap regulasi, pendidikan dan pelatihan, audit, serta pengawasan yang berkesinambungan.

4. Deteksi fraud merupakan proses untuk menemukan sedini mungkin adanya indikasi atau dugaan fraud melalui kegiatan audit, monitoring, analisis data, evaluasi, pengawasan rutin, pelaporan masyarakat, maupun mekanisme *Whistleblowing System* sehingga tindakan korektif dapat segera dilakukan.

5. Investigasi Fraud

Merupakan serangkaian kegiatan pemeriksaan yang dilakukan secara

independen, objektif, profesional, dan terdokumentasi untuk memperoleh bukti yang cukup mengenai adanya dugaan fraud. Hasil investigasi digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan serta penetapan tindak lanjut oleh manajemen rumah sakit.

6. Pelapor (*Whistleblower*) adalah setiap orang yang melaporkan dugaan fraud berdasarkan informasi yang diketahui dengan itikad baik. Pelapor memperoleh perlindungan sepanjang laporan disampaikan secara jujur dan tidak bertujuan memfitnah pihak lain
7. Pengertian Sistem Pelaporan Fraud (*Whistleblowing System / WBS*)
Whistleblowing System (WBS) Anti-Fraud Rumah Sakit adalah sebuah sistem, wadah, atau mekanisme penyampaian pengaduan yang disediakan oleh pihak manajemen bagi setiap karyawan, pasien, maupun mitra kerja untuk melaporkan adanya dugaan tindakan kecurangan (*fraud*), pelanggaran hukum, atau pelanggaran kode etik di lingkungan kerja. Sistem ini dirancang secara khusus untuk menjamin kerahasiaan identitas pelapor secara mutlak serta memberikan perlindungan penuh dari segala bentuk intimidasi, diskriminasi, maupun balasan yang merugikan di kemudian hari.
8. Pengendalian internal merupakan seluruh kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang diterapkan oleh rumah sakit untuk memberikan keyakinan memadai bahwa kegiatan operasional berjalan secara efektif dan efisien, aset organisasi terlindungi, laporan dapat diandalkan, serta seluruh kegiatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan internal.
9. Manajemen Risiko merupakan proses yang dilakukan secara sistematis untuk mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, mengendalikan, serta memantau risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan rumah sakit, termasuk risiko terjadinya fraud.
10. Insiden Fraud merupakan setiap kejadian yang telah terbukti maupun masih diduga mengandung unsur fraud berdasarkan hasil identifikasi awal, audit, monitoring, investigasi, maupun laporan dari pihak yang berwenang.
11. Gratifikasi merupakan pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai atau penyelenggara rumah sakit dalam bentuk uang, barang, rabat, komisi, fasilitas, perjalanan, atau bentuk pemberian lainnya yang berhubungan dengan jabatan dan berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas.
12. Kode etik merupakan seperangkat nilai, norma, dan standar perilaku yang menjadi pedoman bagi seluruh staf rumah sakit dalam menjalankan tugas secara profesional, jujur, bertanggung jawab, berintegritas, serta menjunjung tinggi kepentingan pasien dan organisasi.
13. Staf Rumah Sakit seluruh individu yang bekerja atau melakukan aktivitas di lingkungan rumah sakit, baik sebagai pemilik, komisaris, direksi, tenaga medis, tenaga kesehatan, tenaga nonkesehatan, pegawai tetap, pegawai kontrak, tenaga alih daya, mahasiswa praktik, relawan, mitra kerja, vendor, maupun pihak lain yang memiliki hubungan kerja atau hubungan pelayanan dengan rumah sakit.
14. Pengendalian Fraud merupakan keseluruhan kebijakan, sistem, prosedur, dan kegiatan yang diterapkan oleh rumah sakit untuk mencegah, mendeteksi, menginvestigasi, menangani, serta mengevaluasi setiap kejadian fraud sebagai bagian dari penerapan tata kelola rumah sakit yang baik.
15. Investigasi Internal merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh Tim Anti Fraud atau tim lain yang ditunjuk oleh Direktur terhadap dugaan fraud berdasarkan laporan, hasil audit, monitoring, maupun informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
16. Sanksi merupakan tindakan yang diberikan kepada pelaku fraud sesuai tingkat pelanggaran yang dilakukan, baik berupa sanksi administratif, kepegawaian, perdata, maupun pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan rumah sakit.

-
17. Phantom Billing adalah tindakan mengajukan atau menagihkan biaya pelayanan kesehatan kepada BPJS Kesehatan, perusahaan asuransi, atau penjamin lainnya atas pelayanan, tindakan medis, pemeriksaan penunjang, penggunaan obat, atau pelayanan lain yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada pasien.
 18. Upcoding adalah tindakan mengubah atau meningkatkan kode diagnosis maupun kode tindakan medis menjadi lebih berat atau lebih kompleks dibandingkan kondisi pasien yang sebenarnya dengan tujuan memperoleh pembayaran klaim yang lebih besar dari yang seharusnya diterima.
 19. Kickback (suap) adalah pemberian atau penerimaan komisi, hadiah, uang, fasilitas, atau keuntungan lainnya secara tidak sah dari pihak penyedia barang dan jasa, perusahaan farmasi, atau pihak lain sebagai imbalan atas keputusan tertentu dalam proses pengadaan barang dan jasa, pemberian pelayanan, atau penggunaan produk tertentu di rumah sakit.
 20. Pengertian Tim Pencegahan Kecurangan (TPK) Internal/ Tim Adhoc
 21. Tim Pencegahan Kecurangan (TPK)/ Tim Adhoc adalah unit kerja independen atau komite ad-hoc di bawah pengawasan langsung Direktur Utama dan Satuan Pemeriksaan Internal (SPI) yang bertanggung jawab untuk menyusun kebijakan pencegahan, memonitor potensi risiko di setiap unit pelayanan, memvalidasi laporan masuk, serta melakukan investigasi awal atas indikasi kecurangan demi menjaga kualitas pelayanan, kepatuhan (compliance), dan keselamatan pasien di rumah sakit.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Fraud ini berlaku untuk seluruh kegiatan penyelenggaraan rumah sakit, baik yang berkaitan dengan pelayanan kepada pasien maupun kegiatan pendukung operasional dan tata kelola organisasi. Penerapan pedoman ini tidak hanya terbatas pada pelayanan yang dibiayai oleh BPJS Kesehatan, tetapi juga mencakup pelayanan kepada pasien umum, perusahaan, asuransi, instansi pemerintah, maupun sumber pembiayaan lainnya.

- a. Pelayanan Medis adalah seluruh pelayanan yang diberikan kepada pasien oleh tenaga medis sesuai dengan kewenangan profesinya, mulai dari pelayanan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, hingga pelayanan kedokteran forensik dan pelayanan medis lainnya. Dalam ruang lingkup ini, potensi fraud dapat berupa manipulasi dokumentasi pelayanan, ketidaksesuaian diagnosis dan tindakan, penyalahgunaan kewenangan klinis, maupun bentuk penyimpangan lainnya yang berkaitan dengan pelayanan medis
- b. Penunjang Medis adalah seluruh pelayanan yang mendukung proses diagnosis, terapi, dan rehabilitasi pasien, seperti pelayanan laboratorium, radiologi, farmasi, gizi, CSSD Laundry, rekam medis dan pendaftaran, dan pelayanan penunjang lainnya. Pencegahan fraud pada pelayanan penunjang medis mencakup pengendalian terhadap penggunaan obat dan bahan medis habis pakai, keakuratan hasil pemeriksaan, ketepatan pencatatan pelayanan, serta kepatuhan terhadap prosedur pelayanan. serta melibatkan tenaga kesehatan seperti dokter, perawat, dan bidan,
- c. Pelayanan Bagian Umum adalah seluruh kegiatan nonklinis yang mendukung penyelenggaraan pelayanan rumah sakit, antara lain pengelolaan keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, pengelolaan aset, teknologi informasi, pemasaran, kerja sama, administrasi umum, serta fungsi pendukung lainnya. Pada ruang lingkup ini, potensi fraud dapat berupa penyalahgunaan aset, manipulasi laporan keuangan, pengadaan yang tidak sesuai ketentuan, benturan kepentingan, gratifikasi, penyalahgunaan data dan informasi, maupun bentuk penyimpangan administratif lainnya.

Seluruh kegiatan sebagaimana dimaksud di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari sistem tata kelola rumah sakit sehingga wajib menerapkan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta pengendalian internal sebagai upaya pencegahan dan penanganan fraud.

2.1 Batasan Subjek (Personel yang Terkait)

Pedoman Pencegahan dan Penanganan Fraud ini berlaku dan mengikat bagi seluruh insan Rumah Sakit yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan, kegiatan operasional, administrasi, maupun pengelolaan rumah sakit. Setiap pihak wajib memahami, mematuhi, dan melaksanakan ketentuan yang diatur dalam pedoman ini sesuai dengan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya.

Subjek yang menjadi ruang lingkup penerapan pedoman ini meliputi:

1. Pemilik atau Representasi Pemilik, yaitu pihak yang memiliki kewenangan dalam menetapkan kebijakan strategis, melakukan pembinaan, pengawasan, dan pengendalian terhadap penyelenggaraan rumah sakit.
2. Direksi dan Manajemen Rumah Sakit, meliputi Direktur, pejabat struktural, manajer, kepala bagian, kepala instalasi, kepala unit, serta pejabat lain yang memiliki fungsi pengelolaan dan pengambilan keputusan di lingkungan rumah sakit.

3. Tenaga Medis, meliputi dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi, dokter gigi spesialis, serta tenaga medis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Tenaga Kesehatan, meliputi perawat, bidan, apoteker, tenaga teknis kefarmasian, analis laboratorium, radiografer, nutrisisionis, fisioterapis, perekam medis dan informasi kesehatan, serta tenaga kesehatan lainnya yang memberikan pelayanan kepada pasien.
5. Tenaga Nonkesehatan, meliputi pegawai administrasi, petugas keuangan, petugas pendaftaran, petugas kasir, petugas teknologi informasi, petugas logistik, petugas pengadaan barang dan jasa, petugas keamanan, petugas kebersihan, serta tenaga pendukung lainnya.
6. Satuan Pengawas Internal, Komite, dan Tim yang Dibentuk oleh Direktur, termasuk Tim Anti Fraud, Komite Medik, Komite Keperawatan, Komite Mutu, Komite Etik dan Hukum, serta komite atau tim lainnya yang memiliki fungsi pengawasan, pembinaan, dan pengendalian.
7. Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Alih Daya (Outsourcing) yang melaksanakan pekerjaan di lingkungan rumah sakit berdasarkan perjanjian kerja atau kontrak kerja sama.
8. Mitra Kerja dan Pihak Ketiga, meliputi penyedia barang dan jasa, vendor, distributor, perusahaan farmasi, perusahaan alat kesehatan, kontraktor, konsultan, penyedia jasa alih daya, mitra kerja sama operasional (KSO), perusahaan asuransi, BPJS Kesehatan, serta pihak lain yang memiliki hubungan kerja sama dengan rumah sakit.
9. Pihak Lain yang berdasarkan perjanjian, penugasan, atau ketentuan peraturan perundang-undangan melakukan kegiatan di lingkungan Rumah Sakit atau memiliki hubungan hukum dengan Rumah Sakit.

Seluruh pihak sebagaimana dimaksud di atas berkewajiban menerapkan prinsip integritas, transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan internal Rumah Sakit. Apabila terdapat dugaan atau indikasi fraud, setiap pihak wajib mendukung proses pencegahan, pelaporan, pemeriksaan, investigasi, dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.

2.2 Batasan Objek (Area Kegiatan dan Pelayanan Rawan Fraud)

Pemantauan, pencegahan, dan penanganan kecurangan difokuskan pada klaster area yang memiliki risiko tinggi (*high-risk area*) di RS Prima Husada, antara lain:

1. Area Pelayanan Jaminan Kesehatan (JKN & Asuransi Swasta):
 - a. Proses pengisian, pendokumentasian, dan pengesahan Berkas Rekam Medis (baik cetak maupun Rekam Medis Elektronik/RME).
 - b. Proses penetapan kode diagnosis (ICD-10) dan kode prosedur (ICD-9-CM) oleh petugas koding (*coding*).
 - c. Proses penginputan dan pengiriman (*submit*) berkas klaim ke aplikasi BPJS Kesehatan (E-Vedika) atau portal asuransi komersial.
2. Area Pelayanan Klinis dan Penunjang Medis:
 - a. Pemberian asuhan medis yang berlebihan atau tidak sesuai indikasi klinis (*overutilization*).
 - b. Peresepan obat, alat kesehatan, atau pemeriksaan penunjang (laboratorium/radiologi) yang tidak dibutuhkan pasien.
3. Area Keuangan dan Transaksi Pasien Umum:
 - a. Pengelolaan transaksi pembayaran di kasir dan sistem penagihan (*billing system*) rumah sakit.
 - b. Pengembalian biaya (*refund*) pelayanan atau pembatalan transaksi yang rentan manipulasi.

-
4. Area Pengadaan Barang, Jasa, dan Logistik (*Procurement*):
 - a. Proses tender, pemilihan vendor, investasi alat medis, dan pembelian barang habis pakai (BHP) serta obat-obatan.
 - b. Penerimaan, penyimpanan, dan penyaluran barang logistik farmasi maupun non-farmasi.
 5. Area Manajerial dan Kepegawaian:
 - a. Penyusunan laporan keuangan internal dan eksternal rumah sakit.
 - b. Pengelolaan data kehadiran, lembur, bonus, jasa medis dokter, dan hak keuangan karyawan.

2.3 Batasan Tahapan Operasional (Siklus Anti-Fraud)

Secara operasional, pedoman ini membatasi tata cara kerja rumah sakit ke dalam 4 (empat) pilar utama penanganan *fraud* :

1. Pencegahan (*Prevention*): Meliputi edukasi, penandatanganan pakta integritas, standarisasi regulasi, dan penguatan sistem informasi manajemen (SIMRS).
2. Deteksi Dini (*Detection*): Meliputi pelaksanaan audit medis, audit koding, analisis anomali data bulanan, serta pengelolaan sistem pengaduan pelanggaran (*Whistleblowing System*).
3. Investigasi (*Investigation*): Meliputi tata cara pembentukan Tim Anti-Fraud, pemeriksaan dokumen, klarifikasi saksi/terduga, dan penyusunan Laporan Hasil Investigasi (LHI) secara objektif.
4. Penindakan dan Evaluasi (*Sanction & Remedy*): Meliputi rekomendasi penjatuhan sanksi oleh Direktur, pemulihan kerugian finansial rumah sakit, serta perbaikan sistem (*sistem correction*) agar celah kecurangan yang sama tidak terulang kembali.

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Komitmen Rumah Sakit terhadap Pencegahan dan Penanganan Fraud

Sebagai wujud penerapan **Good Hospital Governance**, pengendalian internal, manajemen risiko, serta budaya integritas, Rumah Sakit berkomitmen untuk:

1. Menerapkan budaya anti fraud sebagai bagian dari budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai integritas, kejujuran, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas;
2. Menerapkan prinsip **zero tolerance against fraud**, yaitu tidak memberikan toleransi terhadap segala bentuk tindakan fraud yang dilakukan oleh setiap insan rumah sakit maupun pihak lain yang memiliki hubungan kerja sama dengan rumah sakit;
3. Membangun dan mengembangkan sistem pengendalian internal yang efektif guna mencegah, mendeteksi, dan meminimalkan risiko terjadinya fraud;
4. Menerapkan manajemen risiko secara terintegrasi melalui proses identifikasi, analisis, evaluasi, pengendalian, dan pemantauan terhadap risiko fraud pada seluruh proses bisnis rumah sakit;
5. Menyediakan mekanisme pelaporan dugaan fraud (*whistleblowing system*) yang mudah diakses, aman, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan;
6. Memberikan perlindungan terhadap pelapor yang beritikad baik dengan menjaga kerahasiaan identitas, informasi, dan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
7. Menindaklanjuti setiap laporan dugaan fraud melalui proses verifikasi dan investigasi yang dilaksanakan secara independen, objektif, profesional, adil, dan berdasarkan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan;
8. Memberikan rekomendasi tindak lanjut dan penjatuhan sanksi terhadap setiap pelaku fraud sesuai dengan tingkat pelanggaran, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta kebijakan internal rumah sakit;
9. Melaksanakan tindakan korektif dan perbaikan sistem sebagai upaya mencegah terulangnya kejadian fraud serta meningkatkan efektivitas pengendalian internal;
10. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan secara berkala terhadap pelaksanaan program pencegahan dan penanganan fraud sebagai bagian dari upaya peningkatan mutu dan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*); dan
11. Meningkatkan kompetensi, kesadaran, dan kepatuhan seluruh insan rumah sakit melalui pendidikan, pelatihan, sosialisasi, serta pembinaan secara berkelanjutan mengenai pencegahan dan penanganan fraud.

3.2 Jenis Fraud di Rumah Sakit

1. Fraud oleh Provider (Rumah sakit / Tenaga Medis)
Ini adalah jenis *fraud* yang paling sering menjadi sorotan karena berdampak langsung pada klaim asuransi atau biaya yang harus dibayar pasien.
 - a. Upcoding
Mengubah kode diagnosis atau prosedur medis menjadi kode yang memiliki tarif klaim lebih mahal daripada kondisi yang sebenarnya ditangani.
 - b. Phantom Billing
Menagihkan biaya pelayanan, obat, atau tindakan yang sebenarnya tidak pernah diberikan kepada pasien.
 - c. Unbundling
Memecah satu paket pelayanan (yang seharusnya diklaim secara paket/all-in) menjadi beberapa komponen terpisah agar total biaya klaim menjadi lebih tinggi.
 - d. Canceling (Klaim Ganda)
Menagihkan biaya untuk satu pelayanan yang sama lebih dari satu kali

-
- (*double billing*).
- e. Readmission
Sengaja memulangkan pasien sebelum kondisinya benar-benar stabil, kemudian memasukkannya kembali ke rumah sakit (re-admisi) dalam waktu singkat hanya untuk membuat klaim baru.
 - f. Inflated Bills
Menggelembungkan biaya obat atau alat kesehatan di luar tarif resmi yang telah ditentukan.
 - g. Keperluan Medis yang Tidak Perlu (Unnecessary Services)
Melakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium, radiologi) atau tindakan medis (misalnya operasi) yang sebenarnya tidak mendesak atau tidak diperlukan secara klinis, demi meningkatkan pendapatan.
2. Fraud oleh Tenaga Medis/ Dokter
Bisa terjadi secara individu atau bekerja sama dengan pihak manajemen/farmasi.
- a. Kehadiran fiktif (*Phantom Provider*)
Mengklaim tindakan medis yang dilakukan oleh dokter tertentu, padahal dokter tersebut tidak hadir atau tindakan dilakukan sepenuhnya oleh tenaga non-medis tanpa supervisi.
 - b. Kecurangan Resep
Sengaja meresepkan obat bermerek tertentu yang lebih mahal karena adanya kesepakatan atau insentif (*kickback*) dari perusahaan farmasi, meskipun ada alternatif obat generik yang sama efektifnya.
 - c. Rujukan Semu
Merujuk pasien ke fasilitas penunjang atau klinik tertentu di mana dokter tersebut memiliki kepentingan finansial di dalamnya, tanpa indikasi medis yang objektif.
3. Fraud Oleh Pasien (Peserta Jaminan)
Pasien atau keluarga pasien juga dapat melakukan kecurangan untuk menghindari biaya atau mendapatkan keuntungan finansial.
- a. Pemalsuan Identitas (*Identity Theft*)
Menggunakan kartu jaminan kesehatan (seperti BPJS atau asuransi) milik orang lain yang masih aktif untuk mendapatkan layanan pengobatan gratis.
 - b. Pemalsuan Dokumen Syarat Klaim
Memalsukan surat rujukan, kartu kepesertaan, atau dokumen pendukung lainnya agar bisa dilayani di fasilitas kesehatan tingkat lanjut.
 - c. Membeli / Menjual Obat Ilegal
Pura-pura sakit untuk mendapatkan resep obat tertentu (terutama obat penenang atau obat mahal), yang kemudian dijual kembali ke pasar gelap.
4. Fraud oleh Sisi manajemen / Administrasi Internal
Terjadi di dalam tata kelola operasional rumah sakit di luar ranah pelayanan klinis langsung
- a. *Procurement Fraud*, yaitu penyimpangan dalam proses pengadaan barang dan jasa, termasuk kolusi, mark-up harga, pengaturan pemenang tender, atau spesifikasi yang menguntungkan pihak tertentu.
 - b. Penyalahgunaan Aset Rumah Sakit, yaitu menggunakan aset, fasilitas, kendaraan, atau inventaris rumah sakit untuk kepentingan pribadi.
 - c. Manipulasi Laporan Keuangan, yaitu mengubah atau menyajikan laporan keuangan yang tidak sesuai kondisi sebenarnya.
 - d. Penggelapan Kas, yaitu mengambil atau menggunakan uang rumah sakit tanpa hak.
 - e. Penyalahgunaan Dana Operasional, yaitu menggunakan anggaran rumah sakit untuk kepentingan pribadi atau di luar peruntukannya.
 - f. Fraud Penggajian (Payroll Fraud), yaitu manipulasi data gaji, lembur, insentif, jasa pelayanan, atau pembayaran kepada pegawai fiktif (*ghost employee*).

- g. Penyalahgunaan Wewenang, yaitu menggunakan jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau memberikan keuntungan kepada pihak tertentu.
5. Fraud dalam Teknologi Informasi
- a. Penyalahgunaan hak akses ke Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) atau Rekam Medis Elektronik (RME).
 - b. Manipulasi atau penghapusan data elektronik tanpa kewenangan.
 - c. Pemalsuan identitas pengguna (*user ID*) atau penggunaan akun milik orang lain.
 - d. Perubahan data transaksi, data pelayanan, atau data klaim secara tidak sah.
 - e. Pencurian, penyebarluasan, atau penyalahgunaan data pasien dan data rumah sakit.
 - f. Serangan siber (*cyber fraud*) yang dilakukan oleh pihak internal maupun eksternal untuk memperoleh keuntungan.

Selain bentuk-bentuk sebagaimana dimaksud di atas, setiap tindakan yang memenuhi unsur kesengajaan, penyalahgunaan kewenangan, manipulasi, pemalsuan, penipuan, penggelapan, kolusi, korupsi, suap, gratifikasi, benturan kepentingan, atau perbuatan lain yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan kebijakan internal rumah sakit sehingga menimbulkan atau berpotensi menimbulkan kerugian bagi rumah sakit, pasien, penjamin, pemerintah, atau pihak lain, dikategorikan sebagai fraud dan ditangani sesuai dengan ketentuan dalam pedoman ini.

3.3 Prinsip Anti Fraud

Prinsip anti-*fraud* di fasilitas kesehatan mengacu pada kerangka kerja pengendalian internal yang ketat, transparansi, dan akuntabilitas. Berikut adalah prinsip-prinsip utama anti-*fraud* yang harus diterapkan di rumah sakit :

1. Tata Kelola dan Komitmen Manajemen (Tone at the Top)
Prinsip ini menekankan bahwa pencegahan kecurangan harus dimulai dari tingkat tertinggi (Direksi dan Manajemen).
 - a. Kebijakan Tertulis
Rumah sakit wajib memiliki regulasi, kode etik (*code of conduct*), dan pedoman pencegahan *fraud* yang jelas dan ditandatangani oleh pimpinan (misalnya mengacu pada PMK No. 16 Tahun 2019).
 - b. Keteladanan Pimpinan
Manajemen harus menunjukkan komitmen nol toleransi (*zero tolerance*) terhadap segala bentuk kecurangan.
2. Penilaian Risiko secara Berkala (Fraud Risk Assessment)
Rumah sakit harus secara proaktif memetakan titik-titik rawan yang paling berpotensi terjadi *fraud*.
 - a. Identifikasi Area Rawan
Memetakan unit yang memiliki risiko tinggi, seperti bagian koding/klaim BPJS, farmasi, pengadaan barang (*procurement*), dan pendaftaran pasien.
 - b. Evaluasi Kontrol
Menilai apakah sistem yang ada saat ini sudah cukup kuat untuk mendeteksi celah kecurangan di area-area rawan tersebut.
3. Pengendalian dan Pengawasan Berlapis
Membangun sistem operasional yang menutup ruang gerak pelaku *fraud* melalui pembagian tugas dan validasi data.
 - a. Pemisahan Fungsi (*Segregation of Duties*)
Memastikan orang yang membuat anggaran, orang yang menyetujui, dan orang yang melakukan pembayaran adalah pihak yang berbeda.
 - b. Kendali Mutu dan Kendali Biaya (KMKB)
Membentuk tim khusus yang melakukan audit klinis dan kesesuaian antara rekam medis dengan kode klaim secara berkala sebelum berkas diajukan ke

- pihak penjamin.
- c. Digitalisasi Terintegrasi
Mengoptimalkan SIMRS (Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit) agar seluruh data tindakan, resep obat, dan billing terkunci otomatis serta tidak bisa diubah secara sepihak tanpa otorisasi berjenjang.
- 4. Transparansi dan Keterbukaan Informasi
Semua proses pelayanan dan administratif harus dapat ditelusuri secara jelas (*auditable*).
 - a. Rekam Medis yang Akurat
Dokumentasi klinis oleh dokter dan perawat harus lengkap, jelas, dan tepat waktu. Rekam medis adalah benteng utama untuk membuktikan bahwa suatu tindakan benar-benar dilakukan atas indikasi medis yang valid.
 - b. Klaim Terbuka
Transparansi biaya kepada pasien (melalui *billing* yang terperinci) dan penyampaian klaim yang jujur kepada pihak asuransi/BPJS.
- 5. Sistem Pelaporan dan Perlindungan Whistleblower
Menyediakan wadah aman bagi siapa saja yang menemukan indikasi kecurangan.
 - a. Whistleblowing System (WBS)
Menyediakan jalur pelaporan yang aman, mudah diakses, dan rahasia bagi karyawan, pasien, atau vendor untuk melaporkan tindakan *fraud*.
 - b. Perlindungan Pelapor
Menjamin kerahasiaan identitas pelapor dari segala bentuk intimidasi atau sanksi balasan dari pihak yang dilaporkan.
- 6. Edukasi dan Budaya Organisasi (Awareness)
Membangun kesadaran kolektif bahwa *fraud* adalah tindakan yang merugikan semua pihak, termasuk reputasi institusi.
 - a. Sosialisasi Berkelanjutan:
Melakukan pelatihan berkala mengenai anti-*fraud* kepada koder, dokter, perawat, dan staf administrasi.
 - b. Membangun Kultur Integritas
Menggeser paradigma staf dari "bagaimana mengoptimalkan pendapatan rumah sakit dengan segala cara" menjadi "bagaimana memberikan pelayanan yang efisien, bermutu, dan sesuai regulasi."

3.4 Potensi Kejadian Fraud di Tiap Unit Rumah Sakit

Fraud (kecurangan) di rumah sakit merupakan tindakan yang disengaja oleh pihak internal maupun eksternal untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok, yang mengakibatkan kerugian pada keuangan rumah sakit atau negara/asuransi. Mengingat kompleksnya alur pelayanan di rumah sakit, potensi fraud bisa terjadi di hampir semua unit kerja. Berikut adalah peta potensi kejadian fraud di tiap unit rumah sakit:

1. Unit Front Office, Registrasi, & Admisi
Unit ini adalah gerbang utama pasien, sehingga rawan terjadi manipulasi data identitas dan kepesertaan asuransi.
 - a. Penyalahgunaan Kartu Asuransi (Identity Theft)
Membiarkan pasien menggunakan kartu BPJS atau asuransi milik orang lain yang masih aktif.
 - b. Upcoding Terselubung di Awal
Mengarahkan pasien secara sengaja ke kelas perawatan yang lebih tinggi tanpa indikasi medis yang sesuai demi tarif yang lebih mahal.
 - c. Manipulasi Status Pasien
Mengubah status pasien umum menjadi pasien jaminan (atau sebaliknya) secara

-
- tidak sah untuk keuntungan finansial oknum.
2. Unit Rawat Jalan (Poliklinik) & IGD
Potensi fraud di unit ini sering kali melibatkan manipulasi kuantitas pelayanan atau tindakan yang tidak perlu.
 - a. Fragmentasi Layanan (Unbundling)
Memecah satu paket pelayanan yang seharusnya satu kesatuan menjadi beberapa tagihan terpisah agar klaimnya lebih besar.
 - b. Tindakan Medis yang Tidak Perlu (Unnecessary Treatment):
Melakukan pemeriksaan penunjang (laboratorium/radiologi) atau tindakan medis yang sebenarnya tidak ada indikasi klinisnya demi mengejar target pendapatan atau komisi.
 - c. Phantom Billing: Mencatat adanya tindakan atau pemeriksaan fisik yang sebenarnya tidak pernah dilakukan kepada pasien ke dalam rekam medis
 3. Unit Rawat Inap & Intensive Care (ICU/NICU/PICU)
Di unit rawat inap, fraud biasanya berkaitan dengan durasi perawatan dan manipulasi tingkat keparahan penyakit.
 - a. Memperpanjang Hari Rawat (Prolonged Stay)
Sengaja menahan pasien lebih lama di rumah sakit melebihi waktu yang dibutuhkan secara klinis demi menaikkan biaya kamar dan jasa.
 - b. Readmisi Sengaja
Memulangkan pasien jaminan yang belum benar-benar sembuh, lalu menyuruhnya masuk kembali beberapa hari kemudian melalui IGD agar rumah sakit bisa mengklaim dua kali paket INA-CBGs.
 - c. Penyalahgunaan Kamar Intensif
Memasukkan atau menahan pasien di ICU/HCU padahal kondisi pasien tidak memerlukan pemantauan intensif, atau sebaliknya, demi tarif klaim yang lebih tinggi.
 4. Unit Kamar Operasi (OK) & Anestesi
Unit dengan biaya tinggi ini rawan terhadap manipulasi prosedur pembedahan.
 - a. Manipulasi Prosedur Operasi
Melaporkan tindakan operasi kecil sebagai operasi sedang/besar (misalnya, melaporkan apendektomi biasa sebagai apendektomi dengan komplikasi berat) agar tarif klaim melonjak.
 - b. Surgical Upcoding
Menambahkan diagnosis sekunder atau komplikasi fiktif pasca-operasi pada berkas klaim.
 5. Unit Penunjang Medis (Farmasi, Laboratorium, Radiologi)
 - a. Farmasi:
 - 1) *Kickback* atau gratifikasi dari vendor obat kepada oknum rumah sakit untuk meresepkan merek obat tertentu.
 - 2) Memberikan obat di bawah dosis yang diresepkan (atau menggantinya dengan jenis yang lebih murah) namun menagih dengan harga penuh.
 - 3) Penulisan resep fiktif atau obat berlebih yang tidak dibawa pulang oleh pasien tetapi ditagihkan ke asuransi.
 - b. Laboratorium & Radiologi:
 - 1) Melakukan pemeriksaan skrining massal atau rutin tanpa indikasi medis khusus.
 - 2) Mencetak ulang hasil rontgen atau lab lama untuk pasien baru dengan kasus serupa (*re-using* hasil penunjang).
 6. Unit Rekam Medis & Casemix (Koding Klaim)
Unit ini adalah "dapur" pengolahan klaim, sehingga menjadi area paling krusial untuk potensi fraud administratif.
 - a. Upcoding
Memilih kode diagnosis atau prosedur yang memiliki bobot tarif lebih tinggi

- (lebih mahal) daripada diagnosis riil yang ditulis oleh dokter.
 - b. Cloning Rekam Medis
Menyalin (*copy-paste*) catatan klinis dari pasien lain yang memiliki diagnosis berat untuk pasien yang gejalanya ringan agar klaimnya lolos.
 - c. Modifikasi Diagnosis Utama
Mengubah diagnosis utama yang tidak dijamin asuransi menjadi diagnosis lain yang dijamin.
7. Unit Pengadaan (Procurement) & Logistik Umum
- Potensi *fraud* di unit non-klinis ini biasanya merugikan internal rumah sakit secara langsung.
- a. Kolusi dan Penggelembungan Harga (Mark-up)
Kongkalikong dengan vendor alat kesehatan atau bahan medis habis pakai (BMHP) untuk menaikkan harga beli.
 - b. Proyek Fiktif / Pengadaan Bayangan
Membuat laporan pembelian barang atau pemeliharaan alat yang sebenarnya tidak pernah ada.
 - c. Pencurian Aset (Asset Misappropriation)
Penggelapan stok obat, alkes, atau inventaris rumah sakit untuk dijual kembali secara pribadi.

3.5 Strategi Anti Fraud

Untuk mengatasi dan meminimalkan potensi fraud (kecurangan) yang telah dipetakan di berbagai unit rumah sakit, manajemen harus menerapkan Strategi Anti-Fraud yang komprehensif. Strategi ini tidak bisa hanya berfokus pada penindakan, melainkan harus mencakup ekosistem hulu ke hilir.

Secara umum, strategi anti-fraud rumah sakit dibagi menjadi 4 pilar utama:

1. Pilar Pencegahan (Prevention)
Pilar ini bertujuan untuk menutup celah dan kesempatan sebelum fraud terjadi.
 - a. Penyusunan Regulasi & Pedoman yang Jelas
Rumah sakit wajib memiliki Pedoman Praktik Klinis (PPK) dan *Clinical Pathway* (CP) yang ketat. Jika dokter memberikan tindakan di luar CP tanpa alasan medis yang sah, sistem dapat langsung mendeteksinya sebagai anomali.
 - b. Membangun Budaya Integritas (Budaya "Zero Fraud")
Melakukan sosialisasi berkala mengenai tata kelola rumah sakit yang baik (*Good Corporate Governance*) dan kode etik karyawan.
 - c. Digitalisasi & Integrasi SIMRS
Mengurangi input data manual. Rekam Medis Elektronik (RME) yang terintegrasi langsung dengan sistem koding (Casemix) dan billing farmasi akan mempersulit oknum yang ingin melakukan *upcoding* atau *phantom billing*.
 - d. Penerapan *Dual Control* & Pemisahan Tugas
Di unit krusial seperti Pengadaan (Procurement) dan Keuangan, pisahkan fungsi yang melakukan pemesanan barang, penerimaan barang, dan pembayaran uang.
2. Pilar Deteksi (Detection)
Pilar ini berfungsi untuk menemukan kejadian fraud secara cepat jika tindakan tersebut lolos dari sistem pencegahan.
 - a. Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (TPK)
Rumah sakit harus memiliki tim khusus anti-fraud (biasanya kolaborasi antara Komite Medik, Satuan Pemeriksaan Internal/SPI, Rekam Medis, dan Casemix) yang rutin mengecek kesesuaian klaim.
 - b. Audit Klinis & Audit Medis Berkala
Mengambil sampel berkas klaim (misalnya klaim BPJS Kesehatan) secara

-
- acak untuk dicocokkan antara catatan asli dokter di rekam medis dengan kode ICD-10 yang diinput ke aplikasi klaim.
- c. Data Mining & Analisis Anomali
Memanfaatkan teknologi untuk menyaring data transaksional. Jika ada pola anomali—misalnya, satu dokter meresepkan obat tertentu jauh lebih tinggi dibanding dokter spesialisasi sama lainnya—sistem akan memberikan *alert*.
 - d. Whistleblowing System (WBS)
Menyediakan saluran pengaduan yang aman dan anonim bagi karyawan, pasien, atau vendor untuk melaporkan kecurigaan fraud tanpa takut diintimidasi.
3. Pilar Investigasi & Penanganan (Investigation)
Ketika deteksi awal menunjukkan adanya indikasi kuat, langkah penyelidikan harus dilakukan secara profesional.
- a. Pemeriksaan Bukti
Tim Auditor atau SPI mengumpulkan bukti-bukti objektif seperti rekaman CCTV, log aktivitas user di SIMRS, dokumen fisik rekam medis, atau bukti transaksi keuangan.
 - b. Klarifikasi/Wawancara Terstruktur
Memanggil pihak terkait (karyawan, dokter, atau bahkan pasien) untuk dimintai keterangan tanpa berasumsi bersalah terlebih dahulu (*presumption of innocence*).
4. Pilar Sanksi & Perbaikan (Resolution & Monitoring)
Langkah akhir untuk memberikan efek jera sekaligus memperbaiki sistem agar kejadian serupa tidak terulang.
- a. Pemberian Sanksi Tegas: Sanksi harus diterapkan tanpa tebang pilih sesuai dengan beratnya pelanggaran, mulai dari teguran tertulis, pemotongan insentif, penundaan kredensial dokter, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga pelaporan ke ranah hukum pidana.
 - b. Metode PDSA (Plan-Do-Study-Act): Setiap kali ditemukan modus fraud baru, manajemen harus melakukan Root Cause Analysis (RCA) dan menggunakan siklus PDSA untuk langsung memperbarui SOP, memperbaiki sistem IT, atau memperketat pengawasan di unit terkait.
 - c. Pengembalian Kerugian: Mewajibkan oknum atau mengoreksi klaim ke pihak asuransi/BPJS untuk mengembalikan kerugian finansial yang ditimbulkan akibat fraud tersebut.

3.6 Sistem dan Alur Pelaporan

Sistem dan alur pelaporan fraud di rumah sakit harus dirancang secara aman, rahasia, dan terstruktur agar setiap karyawan atau pihak eksternal berani melapor tanpa takut akan intimidasi atau pembalasan.

Berikut adalah panduan menyusun sistem dan alur pelaporan insiden fraud di rumah sakit:

1. Sistem Pelaporan: *Whistleblowing System* (WBS)
Rumah sakit perlu menyediakan berbagai kanal pelaporan yang dikelola secara independen (biasanya di bawah Satuan Pemeriksaan Internal atau Tim Pencegahan Kecurangan). Kanal tersebut dapat berupa:
 - a. Kotak Pengaduan Fisik
Diletakkan di area yang tidak tersorot CCTV secara langsung demi menjaga privasi pelapor.
 - b. Kanal Digital (Paling Direkomendasikan)
Menggunakan formulir daring khusus (Google Form/aplikasi SIMRS internal) dengan opsi enkripsi nama/anonim.
2. Prinsip Utama Sistem
 - a. Anonymity & Confidentiality

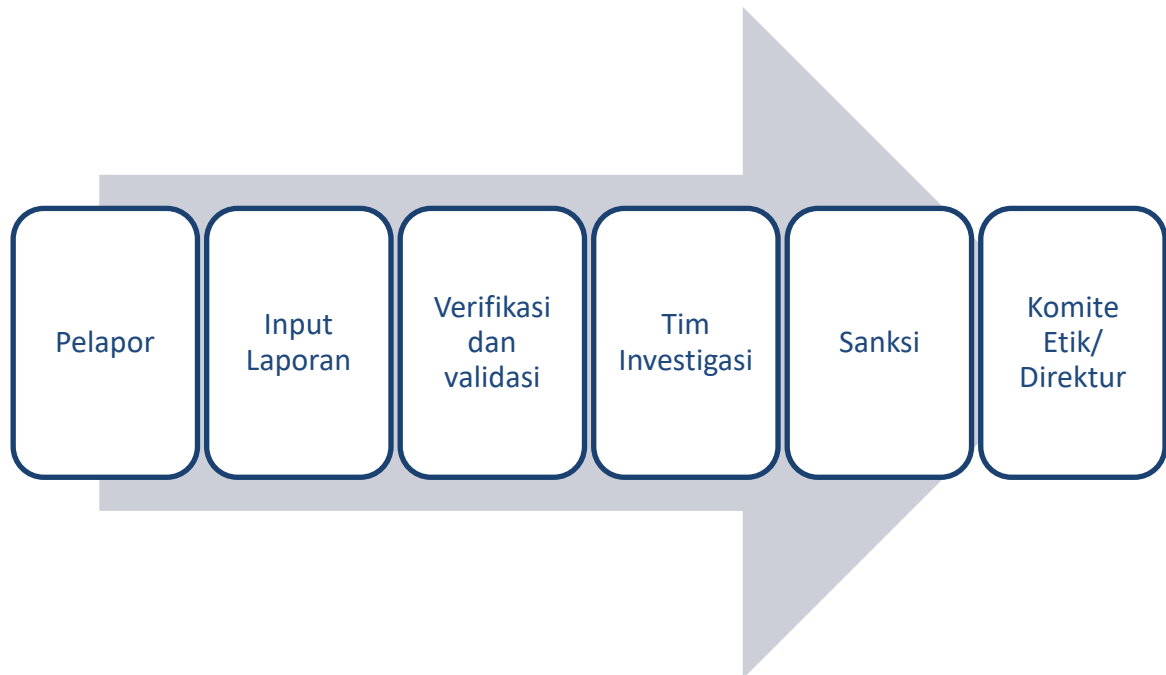
Identitas pelapor dijamin kerahasiaannya 100%.

b. Non-Retaliation Policy

Perlindungan mutlak bagi pelapor dari sanksi sepihak, mutasi yang merugikan, atau pemecatan.

3. Alur Pelaporan dan Penanganan Insiden *Fraud*

Alur pergerakan laporan dirancang melalui 5 tahapan utama dari hulu ke hilir:



a. Tahap Penerimaan laporan

- 1) Pelapor
- 2) Pelapor mengisi formulir laporan dengan prinsip 4W + 1H
 - a) What
 - b) Who
 - c) Where dan When
 - d) How

b. Tahap Penapisan

- 1) Laporan masuk dan diterima oleh kepala bidang dan dibentuk tim adhoc
- 2) Tim adhoc melakukan telaah maksimal 3x 24 jam untuk menentukan relevan dengan kategori fraud, dan bukti untuk dilakukan tindak lanjut
- 3) Jika laporan lemah dan ada unsur sentimen / fitnah maka akan diarsipkan

c. Tahap Investigasi

- 1) Membuat Tim Adhoc
- 2) Tim mengumpulkan bukti secara mendalam

d. Tahap pelaporan hasil dan rekomendasi

- 1) Tim menyusun laporan hasil investigasi yang berisi kronologi, nominal kerugian rumah sakit, serta daftar bukti yang sah
- 2) Laporan hasil investigasi diberikan kepada direktur atau Dewan Pengawas jika fraud melibatkan jajaran direksi beserta rekomendasi perbaikan sistem dan sanksi

e. Tahap eksekusi dan tindak lanjut

- 1) Pemberian sanksi
Direksi mengeksekusi sanksi kepada terlapor yang terbukti bersalah sesuai dengan beratnya pelanggaran dan regulasi internal
- 2) Perbaikan siklus (PDSA)
Unit tempat terjadinya fraud wajib melakukan evaluasi. Alur SIMRS yang jebol atau SOP yang longgar segera direvisi agar modus serupa tidak bisa ditembus

lagi di kemudian hari.

3) Feedback ke Pelapor

Tim memberikan notifikasi singkat kepada pelapor (jika identitasnya diketahui) bahwa laporan telah selesai ditindaklanjuti, sebagai bentuk transparansi

BAB IV

PENUTUP

Pedoman pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud). ini disusun sebagai acuan dalam penyelenggaraan pengelolaan pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan seluruh staf dapat memahami dan melaksanakan pedoman ini secara konsisten.

Dengan ditetapkannya pedoman pencegahan dan penanganan kecurangan (fraud) ini, seluruh unit kerja wajib melaksanakan ketentuan yang tercantum secara konsisten dan bertanggung jawab. Kepatuhan terhadap pedoman ini menjadi bagian dari upaya peningkatan mutu pelayanan, keselamatan pasien, serta pemenuhan standar akreditasi rumah sakit. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan akan dilakukan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi dan kebutuhan pelayanan.

Malang , 05 November 2025

PLT Direktur Rumah Sakit Prima Husada



dr. Resti Lestantini, M. Kes